

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 교수님 뵈 받아서 수업 진도 안나가고 임상 케이스 얘기하셨습니다. 시험에는 출제되지 않을거 같습니다.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

임상 케이스**1) 눈이 피로하다**

- 환자 특징: (체격 있고 얼굴 좀 벌겋다.)이전 병원에서 어떤 치료를 받았는지, 어떤 치료를 받았는지에 대해 물어보는 것이 중요> 타병원에서 해결하지 못 한 것이니 근육, 신경학적으로 접근하여 안륜근, 후두하근 등을 치료 목표로 잡음
- 재진 시에 호전 정도에 대해 체크할 때, 악화되었는지도 물어봐서 고려한다.
- 호전도 없고 증상이 그대로인 경우이더라도 환자에 대한 정보를 계속해서 얻을 수 있고 얻은 정보를 바탕으로 이후 접근 방법을 바꿔서 활용할 수 있다.

-> **바로 낮게 하겠다는 마인드보다 정보를 계속 얻는 것이 중요(특히 노인은 빨리 해결할 수 있다고 접근하지 않기)**

2) 키보드를 칠 때 손가락이 구부러진다(4,5지, 좌측)

- 환자 특징: (40대 초반 여성 직장인, 눈이 크고 무서운 인상) o/s을 확인(3개월)> 증상이 갑자기 발생했는지, 점차 심해졌는지 확인(넘어진 이벤트가 있었음)> 점차 심해지기까지 얼마나 걸렸나(1개월, 한달 만에 신경외과 가서 목디스크 진단 > 신경과에 가서 근긴장이상증 진단 받음)> 파킨슨 고려해서 레보도파 먹는지 확인하고 어떤 약 먹고 있는지 확인(리리카(신경 전달 억제 약) 사용중)> 척골신경 가이딩하여 포착되어 있는 부위 확인하여 치료(혈종이 발생했었는데 증상 별로 심해지지 않음)
- 위 케이스는 양방에서 근긴장이상증으로 진단 내리고 양약을 처방한 환자를 말초부위의 신경 포착을 고려하여 치료한 케이스이다.

-**실제로 치료 받자마자 바로 좋아지진 않았지만 치료 방법이 맞더라도 바로바로 빠르게 회복되지는 않을 수 있다.**

3) 항상 귀가 먹먹하다

- 환자 특징: 60대 초반 사무직, 항상 왼쪽 귀가 먹먹함, 편측성이고 이충만감, 기름진 것 먹으면 증상 심해짐, 이비인후과에서는 문제가 없는 것으로 확인됨
- **귀 먹먹하다고 해서 무조건 약을 바로 사용할 건인가?: 초진에서 약을 권하는 것은 오프라이스 먹으러 왔는데 스테이크 추천하는 격이다.**
- 증상이 아침에 심해지는 경우에 목을 고려, 저녁에 일 오래해서 심해지는 경우에도 목을 고려하여 접근
- 교수님은 해당 환자에게 익돌근 추나를 통해 약간 개선을 확인하였다.
- 귀 먹먹하다고 귀에 좋은 한약 쓸 생각을 하는 것보다 비염 문제가 있는지, GERD가 있는지, 신경이나 근육 문제가 있는지 고려하는 것이 우선이다.

4) 허리 통증

- 순환과 신경으로 접근하는 것이 교수님의 접근법
- 환자 특징: 갱년기인 60대 여성 환자(부자)
- 산후의 경우는 인대가 약해져서 불안정성이 증가하고 이는 허리 통증과 연관된다.
- 환자를 치료할 때, 강도를 점차적으로 올려야 하며, 자신이 활용할 수 있는 기술이 많더라도 조심해서 접근해야 한다.(환자는 여러 연부조직의 불안정성이 증가되어 있고, 호르몬 문제도 있고 정신적으로도 약해져 있기 때문)
- 섬유근육통 느낌의 스트레스 정도도 높고, 이전 검사에서 기질적 문제를 확인하기 어려운 경우> 통증이 일상을 무너뜨렸다는 생각을 개선하고 다른 치료법들(운동법, 산책 등)을 활용
- **정신증이 주된 원인인 경우에 이를 환자에게 인식하도록 하는 것이 아닌 오히려 치료가 되어서 행복해졌을 때를 생각하게 한다.(말로 치료하는 것도 중요)**